

American Psychiatric Association

DSM-5[®]

MANUEL DIAGNOSTIQUE ET STATISTIQUE DES TROUBLES MENTAUX



Coordination générale de la traduction française
Marc-Antoine Crocq et Julien Daniel Guelfi



Directeurs de l'équipe de la traduction française
**Patrice Boyer, Marc-Antoine Crocq, Julien Daniel Guelfi,
Charles Pull, Marie-Claire Pull-Erpelding**

<http://doctidoc2.blogspot.com>

DSM-5[®]

MANUEL DIAGNOSTIQUE ET STATISTIQUE DES TROUBLES MENTAUX

American Psychiatric Association

Officers 2012-2013

President Dilip V. Jeste, M.D.
President-Elect Jeffrey A. Lieberman, M.D.
Treasurer David Fassler, M.D.
Secretary Roger Peele, M.D.

Assembly

Speaker R. Scott Benson, M.D.
Speaker-Elect Melinda L. Young, M.D.

Board of Trustees

Jeffrey Akaka, M.D.
Carol A. Bernstein, M.D.
Brian Crowley, M.D.
Anita S. Everett, M.D.
Jeffrey Geller, M.D., M.P.H.
Marc David Graff, M.D.
James A. Greene, M.D.
Judith F. Kashtan, M.D.
Molly K. McVoy, M.D.
James E. Niningger, M.D.
John M. Oldham, M.D.
Alan F. Schatzberg, M.D.
Alik S. Widge, M.D., Ph.D.

Erik R. Vanderlip, M.D.,
Member-in-Training Trustee-Elect

American Psychiatric Association

DSM-5[®]

MANUEL DIAGNOSTIQUE ET STATISTIQUE DES TROUBLES MENTAUX

5^e édition

Coordination générale de la traduction française

Marc-Antoine Crocq et Julien Daniel Guelfi

Directeurs de l'équipe de la traduction française

**Patrice Boyer, Marc-Antoine Crocq, Julien Daniel Guelfi,
Charles Pull, Marie-Claire Pull-Erpelding**



ELSEVIER
MASSON



Ce logo a pour objet d'alerter le lecteur sur la menace que représente pour l'avenir de l'écrit, tout particulièrement dans le domaine universitaire, le développement massif du « photo-copillage ». Cette pratique qui s'est généralisée, notamment dans les établissements d'enseignement, provoque une baisse brutale des achats de livres, au point que la possibilité même pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd'hui menacée.

Nous rappelons donc que la reproduction et la vente sans autorisation, ainsi que le recel, sont passibles de poursuites. Les demandes d'autorisation de photocopier doivent être adressées à l'éditeur ou au Centre français d'exploitation du droit de copie : 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris. Tél. 01 44 07 47 70.

First Published in the United States by American Psychiatric Association Publishing, A Division of American Psychiatric Association, Arlington, VA. Copyright © 2013. All rights reserved.

First Published in France by Elsevier Masson SAS in French. Elsevier Masson SAS is the exclusive publisher of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health Disorders, Fifth Edition in French for distribution worldwide.

Permission for use of any material in the translated work must be authorized in writing by Elsevier Masson SAS.

The American Psychiatric Association played no role in the translation of this publication from English to the French language and is not responsible for any errors, omissions, or other possible defects in the translation of the publication.

Première publication aux États-Unis par les Éditions de l'Association américaine de psychiatrie, une division de l'Association américaine de psychiatrie, Arlington, VA. Copyright © 2013. Tous droits réservés.

Première publication en France par Elsevier Masson SAS en français. Elsevier Masson SAS est l'éditeur exclusif du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 5^e édition en français pour la distribution dans le monde entier.

La permission d'utiliser toute substance de ce travail de traduction doit faire l'objet d'une autorisation écrite d'Elsevier Masson SAS.

L'Association américaine de psychiatrie n'a joué aucun rôle dans la traduction française de cette publication anglaise et n'est pas responsable des erreurs, omissions ou défauts éventuels de la traduction.

Couverture inspirée de la version allemande du DSM 5 éditée par Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG. Graphiste : Daniel Kleimenhagen, Designer AGD. Adaptée par Véronique Lentaigne.

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés, réservés pour tous pays.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d'autre part, les courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle elles sont incorporées (art. L. 122-4, L. 122-5 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle).

© 2015. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

ISBN : 978-2-294-73929-3

e-ISBN : 978-2-294-74338-2

Elsevier Masson SAS, 62, rue Camille-Desmoulins, 92442 Issy-les-Moulineaux cedex
www.elsevier-masson.fr

Traduction française du DSM-5

Directeurs de l'équipe de la traduction française du DSM-5

Patrice BOYER, professeur à l'Université Paris Diderot, ancien président de l'Association européenne de psychiatrie, psychiatre, clinique des maladies mentales et de l'encéphale, CH Sainte-Anne, Paris.

Marc-Antoine CROCQ, psychiatre, maison des adolescents du Haut-Rhin, CAMUHA, Université de Haute-Alsace, Mulhouse.

Julien Daniel GUELF, professeur émérite de l'Université Paris Descartes, ancien chef de service de la clinique des maladies mentales et de l'encéphale, CH Sainte-Anne, Paris.

Charles PULL, professeur associé à l'Université du Luxembourg, psychiatre, psychothérapeute, Luxembourg.

Marie-Claire PULL-ERPELDING, docteur en psychologie, psychothérapeute, Luxembourg.

Équipe de la traduction française du DSM-5

Mocrane ABBAR, psychiatre, chef du service psychiatrie A3, CHU Carémeau, Nîmes.

Saena ARBABZADEH-BOUCHEZ, praticien hospitalier, service de psychiatrie, GH Lariboisière-Fernand Widal (AP-HP), Paris.

Amine BENYAMINA, professeur des universités, praticien hospitalier, Centre d'enseignement, de recherche et de traitement des addictions, CHU Paul Brousse (AP-HP), Université Paris-Sud 11, Inserm U669, Paris.

Alexis BOEHRER, psychologue clinicien, Université de Haute Alsace.

Jean-Philippe BOULENGER, professeur des universités, praticien hospitalier, responsable du pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie, service universitaire de psychiatrie adulte (SUPA), hôpital de la Colombière, CHRU de Montpellier.

Clara BRICHANT-PETITJEAN, chef de clinique assistante, service de psychiatrie adulte, GH Lariboisière-Fernand Widal (AP-HP), Paris.

Florence BUTLEN-DUCUING, psychiatre, Central Nervous System office, The European Medicines Agency (EMA), London.

Jean-Christophe CHAUVET-GELINIER, praticien hospitalier, service de psychiatrie et d'addictologie, pôle neurosciences, hôpital général, CHU de Dijon.

Jean-Pierre CLÉMENT, psychiatre, professeur des universités, praticien hospitalier, responsable du pôle universitaire de psychiatrie de l'adulte et de la personne âgée, CH Esquirol, Limoges.

Emmanuelle CORRUBLE, professeur des universités, praticien hospitalier, Inserm UMR 1178, équipe « Dépression et antidépresseurs », faculté de médecine Paris Sud et service de psychiatrie, hôpital de Bicêtre, Hôpitaux Universitaires Paris-Sud (AP-HP), Le Kremlin-Bicêtre.

Renaud DE BEAUREPAIRE, praticien hospitalier, chef de pôle de psychiatrie, secteur 94G11, GH Paul-Guiraud, Villejuif.

Steeves DEMAZEUX, agrégé, docteur en philosophie, maître de conférences en philosophie des sciences, Université Bordeaux-Montaigne et laboratoire SPH (EA 4574), Bordeaux.

Colomba DURR, psychologue, maison des adolescents du Haut-Rhin, Mulhouse.

Didier DUTOIT, psychiatre, ancien chef de clinique assistant à la faculté de Lille, cabinet psy liberté, clinique de la Maison Fleurie, Faches Thumesnil.

Benoît DUTRAY, pédopsychiatre, praticien hospitalier, chef du pôle de psychiatrie enfant adolescent, CH de Rouffach.

Felicia DUTRAY, psychiatre, praticien hospitalier, équipe mobile psychiatrie et précarité, pôle 2/3, CH de Rouffach.

Wissam EL HAGE, professeur de psychiatrie d'adultes, clinique psychiatrique universitaire, CHRU de Tours, université François Rabelais, unité Inserm U930 « Imagerie et cerveau », Tours.

Pascal FAVRÉ, praticien hospitalier, chef de pôle secteur 93 G 16, EPS Ville-Évrard.

Florian FERRERI, maître de conférences des universités, praticien hospitalier, service de psychiatrie et de psychologie médicale, hôpital Saint-Antoine (AP-HP), UPMC, Sorbonne Universités, Paris.

Jack FOUCHER, neurologue et psychiatre, maître de conférences des universités, praticien hospitalier, Centre de neuromodulation non invasive de Strasbourg (CEMNIS), hôpitaux universitaires de Strasbourg, Icube, UMR CNRS 7357, Strasbourg.

Nicolas FRANCK, professeur des universités, praticien hospitalier, service universitaire de réhabilitation, université Claude Bernard Lyon 1, centre référent lyonnais en réhabilitation et en remédiation cognitive (CL3R), CH Le Vinatier, Bron.

David GOURION, psychiatre, Paris.

Bernard GRANGER, professeur des universités, praticien hospitalier, responsable de l'unité de psychiatrie et d'addictologie, hôpital Tarnier, Université Paris-Descartes, Paris.

Emmanuel HAFFEN, professeur des universités, praticien hospitalier, service de psychiatrie de l'adulte, CIC-1431, FHU Increase, CHU de Besançon et EA Neurosciences 481, Université de Franche-Comté.

Bertrand HANIN, psychiatre, psychanalyste, Paris.

Chantal HENRY, professeur des universités, praticien hospitalier, pôle de psychiatrie et d'addictologie des hôpitaux universitaires Henri Mondor, hôpital Albert Chenevier (AP-HP), Créteil.

Thierry HERGUETA, psychologue clinicien, laboratoire de psychopathologie et processus de santé – EA 4057, Institut de psychologie, Université Paris Descartes - Sorbonne Paris Cité, Centre des maladies cognitives et comportementales, département de neurologie, GH Pitié Salpêtrière-Charles Foix (AP-HP).

Yann HODÉ, psychiatre, docteur ès sciences, praticien hospitalier, antenne du Haut Rhin du Centre expert régional schizophrénie, CH de Rouffach.

Jérôme HOLTZMANN, praticien hospitalier, unité médicale des troubles de l'humeur et pathologie des émotions, pôle de psychiatrie et neurologie, CHU de Grenoble.

Nematollah JAAFARI, professeur des universités, praticien hospitalier, service hospitalo-universitaire de psychiatrie et de psychologie médicale, unité de recherche clinique intersectorielle en psychiatrie à vocation régionale Pierre Deniker, CH Henri Laborit, Inserm CIC-P 1402, Inserm U 1084 laboratoire expérimental et clinique en neurosciences, Université de Poitiers, groupement de recherche CNRS 3557, CHU de Poitiers.

Frédéric KOCHMAN, pédopsychiatre coordinateur, clinique Lautréamont, Loos.

Frédéric LIMOSIN, professeur des universités, praticien hospitalier, service de psychiatrie de l'adulte et du sujet âgé, Université Paris Descartes, Hôpitaux Universitaires Paris Ouest (AP-HP).

Pierre-Michel LLORCA, professeur de psychiatrie, chef de service du centre médico-psychologique B, CHU de Clermont-Ferrand, vice-président de l'Université d'Auvergne.

Marc MASSON, psychiatre, coordinateur médical, clinique du Château de Garches.

Jean-Albert MEYNARD, psychiatre, chef de service, hôpital Marius Lacroix, La Rochelle.

Raluca MORARU, psychiatre, praticien hospitalier, pôle 2/3, CH de Rouffach.

Guy PARMENTIER, psychiatre, Albi.

Antoine PELISSOLO, professeur des universités, praticien hospitalier, chef de service, pôle de psychiatrie et d'addictologie, Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor (AP-HP), Créteil.

François PETITJEAN, psychiatre des hôpitaux, CHS Ainay-le-Château.

Xenia PROUDNIKOVA, psychiatre, praticien attaché, CH de Rouffach.

Diane PURPER-OUAKIL, professeur des universités, praticien hospitalier, chef de pôle adjoint (pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie), responsable d'équipe médicale, médecine psychologique de l'enfant et de l'adolescent – intersecteur 1, hôpital Saint-Éloi, CHRU de Montpellier.

Frédéric RAFFAITIN, psychiatre, Paris.

Jérémie SINZELLE, psychiatre, Paris.

Luc STANER, psychiatre, praticien hospitalier, responsable de l'unité d'exploration des rythmes veille-sommeil, CH de Rouffach.

Pierre VIDAILHET, professeur des universités, praticien hospitalier, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Inserm U 1114.

Lionel WAINTRAUB, psychiatre, docteur ès sciences, ancien chef de clinique, psychiatre des hôpitaux, clinique du Château, Garches.

Laure WOLGENSINGER, psychologue, pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, CH de Rouffach.

Remerciements pour leur validation translinguistique

Philip GORWOOD, professeur des universités, praticien hospitalier, Université Paris Descartes, chef de service, Clinique des maladies mentales et de l'encéphale (CMME), CH Sainte-Anne, Paris.

Pierre LALONDE, psychiatre, programme des troubles psychotiques, Institut universitaire en santé mentale de Montréal, Professeur émérite, département de psychiatrie, faculté de médecine, Université de Montréal.

Georges F. PINARD, psychiatre, clinique ambulatoire de santé mentale, hôpital Maisonneuve-Rosemont, Montréal, professeur agrégé de clinique, département de psychiatrie, faculté de médecine, Université de Montréal.

Remerciements pour leur aide et conseils

Marc AURIACOMBE, professeur des universités – praticien hospitalier, pôle addictologie, centre hospitalier Charles Perrens, Bordeaux, UFR sciences médicales Segalen, Université Bordeaux 2.

Lisa BLECHA, praticien hospitalier, Centre d'enseignement, de recherche et de traitement des addictions, CHU Paul Brousse, Villejuif, AP-HP.

Frédérique BONNET-BRILHAULT, professeur des universités, praticien hospitalier, centre universitaire de pédopsychiatrie, hôpital Bretonneau, CHRU de Tours.

Jean COTTRAUX, psychiatre honoraire des hôpitaux, ancien chargé de cours à l'université Lyon 1, directeur scientifique de l'Institut francophone de formation et de recherche en thérapie comportementale et cognitive.

Philippe COURTET, professeur de psychiatrie, Université de Montpellier, département d'urgences & post-urgences psychiatriques, pôle urgences, hôpital Lapeyronie, CHRU de Montpellier.

Isabelle JALENQUES, professeur, service de psychiatrie d'adultes A et psychologie médicale, responsable du pôle de psychiatrie, CHU de Clermont-Ferrand.

Louis JEHEL, professeur des universités, praticien hospitalier, chef du service de psychiatrie et psychologie médicale, psychotraumatologie et addictologie, hôpital Pierre-Zobda-Quitman, CHU de Martinique, président de l'AFORCUMP-SFP (Société française de psychotraumatologie), Université des Antilles.

Jean-Pierre ROLLAND, docteur en psychologie, professeur émérite des universités, Université Paris Ouest, Nanterre.

Page laissée en blanc intentionnellement.

Avant-propos à la traduction française du DSM-5

La traduction française du DSM-III a été publiée en 1983, trois années après la publication du Manuel aux États-Unis. Sous la supervision générale de notre Maître Pierre Pichot pour l'ensemble des traductions françaises, italiennes et espagnoles, nous étions alors une équipe de 7 traducteurs et nous avons bénéficié des conseils de Marc Bourgeois. L'équipe s'est élargie par la suite avec le DSM-III-R, puis le DSM-IV en 1994 et le DSM-IV-TR en 2000 ; Norman Sartorius était alors notre conseiller à la traduction.

Aujourd'hui, deux années après la publication du DSM-5 en mai 2013 aux États-Unis, l'équipe de traduction française s'est considérablement élargie, avec toutefois le même comité de direction constitué de : Marc-Antoine Crocq, Julien Daniel Guelfi, Patrice Boyer, Charles Pull et Marie-Claire Pull. Cinquante-deux traducteurs ont été impliqués dans ce travail. Deux psychiatres canadiens ont aussi participé à nos choix : Pierre Lalonde et Georges Pinard.

Nous sommes restés fidèles à nos options de 1983, à savoir traduire plutôt qu'adapter et respecter le style du texte américain, avec ses répétitions systématiques et délibérées.

Nous nous sommes cependant autorisés à ne pas traduire en français systématiquement le mot *Disorder* lorsque cela nous paraissait préférable pour alléger le texte pour des oreilles francophones. Ainsi, à titre d'exemple, le *trouble : tic* ou le trouble : déficit de l'attention/hyperactivité sont devenus au fil des pages *tics* ou déficit de l'attention/hyperactivité.

Nous pensons – comme il y a trente-cinq années – que le travail considérable de nos collègues américains était indispensable, salutaire et que l'élaboration d'un langage commun de base est incontournable. Mais nous pensons aussi que le DSM n'est qu'un outil de travail, qu'il doit être périodiquement révisé et qu'il ne représente ni la somme ni l'aboutissement de la connaissance nosographique en psychiatrie. Nous pensons aussi qu'il existe assurément de nombreux risques de mésusage du DSM et qu'il est nécessaire de dénoncer ceux-ci. Nous estimons cependant que l'utilisation du DSM, conjointement à celle de la Classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé et à celle d'autres systèmes de classification psychiatrique à valeur potentiellement heuristique, est préférable au boycott de l'ouvrage américain que certains préconisent.

Et nous n'avons pas l'impression que l'emploi de la classification américaine nous empêche de penser la psychopathologie.

Nous remercions vivement Claire Guilbert, assistante de rédaction, qui nous a considérablement aidés à homogénéiser les propositions initiales de traduction et à éviter de nombreux écueils. Nous remercions aussi plusieurs collègues qui nous ont aidés à choisir entre plusieurs options de traduction : Marc Auriacombe, Frédérique Bonnet-Brilhault, Philippe Courtet, Isabelle Jalenques et Louis Jehel.

Nous remercions enfin pour leurs avis les membres de la commission spécialisée de néologie et de terminologie qui mène ses travaux au ministère des Affaires sociales et de la Santé sous le pilotage de Mme Catherine Desmares et du Dr Jean-François Dreyfus.

Page laissée en blanc intentionnellement.

Sommaire

Traduction française du DSM-5	v
Avant-propos à la traduction française du DSM-5	ix
Task Force du DSM-5	xiii
Classification du DSM-5	xix
Préface	liii

Section I **Les fondements du DSM-5**

Introduction	3
Utilisation du manuel	21
Mise en garde pour l'usage médico-légal du DSM-5	29

Section II **Critères diagnostiques et codes**

Troubles neurodéveloppementaux	33
Spectre de la schizophrénie et autres troubles psychotiques	109
Troubles bipolaires et apparentés	157
Troubles dépressifs	193
Troubles anxieux	237
Troubles obsessionnels-compulsifs et apparentés	299
Troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress	343
Troubles dissociatifs	379
Troubles à symptomatologie somatique et apparentés	403
Troubles des conduites alimentaires et de l'ingestion d'aliments	429
Troubles du contrôle sphinctérien	463
Troubles de l'alternance veille-sommeil	471

Dysfonctions sexuelles	553
Dysphorie de genre	593
Troubles disruptifs, du contrôle des impulsions et des conduites	605
Troubles liés à une substance et troubles addictifs	631
Troubles neurocognitifs	775
Troubles de la personnalité	841
Troubles paraphiliques	891
Autres troubles mentaux	921
Troubles des mouvements et autres effets indésirables induits par un médicament	923
Autres situations pouvant faire l'objet d'un examen clinique . . .	933

Section III

Mesures et modèles émergents

Mesures d'évaluation	951
Formulation culturelle	971
Modèle alternatif pour les troubles de la personnalité du DSM-5	985
Affections proposées pour des études supplémentaires	1011

Annexes

Principaux changements entre le DSM-IV et le DSM-5	1045
Glossaire des termes techniques	1057
Glossaire des concepts culturels de détresse	1077
Liste alphabétique des diagnostics et codes du DSM-5 (CIM-9-MC et CIM-10-MC)	1089
Liste numérique des diagnostics et codes du DSM-5 (CIM-9-MC)	1117
Liste numérique des diagnostics et codes du DSM-5 (CIM-10-MC)	1135
Conseillers et autres contributeurs du DSM-5	1161
Index	1185

Task Force du DSM-5

DAVID J. KUPFER, M.D.

Task Force Chair

DARREL A. REGIER, M.D., M.P.H.

Task Force Vice-Chair

William E. Narrow, M.D., M.P.H., *Research Director*

Susan K. Schultz, M.D., *Text Editor*

Emily A. Kuhl, Ph.D., *APA Text Editor*

Dan G. Blazer, M.D., Ph.D., M.P.H.

Jack D. Burke Jr., M.D., M.P.H.

William T. Carpenter Jr., M.D.

F. Xavier Castellanos, M.D.

Wilson M. Compton, M.D., M.P.E.

Joel E. Dimsdale, M.D.

Javier I. Escobar, M.D., M.Sc.

Jan A. Fawcett, M.D.

Bridget F. Grant, Ph.D., Ph.D. (2009-)

Steven E. Hyman, M.D. (2007-2012)

Dilip V. Jeste, M.D. (2007-2011)

Helena C. Kraemer, Ph.D.

Daniel T. Mamah, M.D., M.P.E.

James P. McNulty, A.B., Sc.B.

Howard B. Moss, M.D. (2007-2009)

Charles P. O'Brien, M.D., Ph.D.

Roger Peele, M.D.

Katharine A. Phillips, M.D.

Daniel S. Pine, M.D.

Charles F. Reynolds III, M.D.

Maritza Rubio-Stipec, Sc.D.

David Shaffer, M.D.

Andrew E. Skodol II, M.D.

Susan E. Swedo, M.D.

B. Timothy Walsh, M.D.

Philip Wang, M.D., Dr.P.H. (2007-2012)

William M. Womack, M.D.

Kimberly A. Yonkers, M.D.

Kenneth J. Zucker, Ph.D.

Norman Sartorius, M.D., Ph.D., *Consultant*

Équipe de division de recherche sur le DSM-5 de l'APA

Darrel A. Regier, M.D., M.P.H., *Director, Division of Research*

William E. Narrow, M.D., M.P.H., *Associate Director*

Emily A. Kuhl, Ph.D., *Senior Science Writer ; Staff Text Editor*

Diana E. Clarke, Ph.D., M.Sc., *Research Statistician*

Jennifer J. Shupinka, *Assistant Director, DSM Operations*

Seung-Hee Hong, *DSM Senior Research Associate*

Anne R. Hiller, *DSM Research Associate*

Alison S. Beale, *DSM Research Associate*

Spencer R. Case, *DSM Research Associate*

Lisa H. Greiner, M.S.S.A., *DSM-5 Field Trials Project Manager*

Eve K. Moscicki, Sc.D., M.P.H., *Director, Practice Research Network*

S. Janet Kuramoto, Ph.D. M.H.S., *Senior Scientific Research Associate, Practice Research Network*

Joyce C. West, Ph.D., M.P.P., *Health Policy Research Director, Practice Research Network*

Farifteh F. Duffy, Ph.D., *Quality Care Research Director, Practice Research Network*

Lisa M. Countis, *Field Operations Manager, Practice Research Network*

Amy Porfiri, M.B.A., *Director of Finance and Administration*

Christopher M. Reynolds, *Executive Assistant*

Directeur médical du bureau de l'APA

JAMES H. SCULLY JR., M.D.

Medical Director and CEO

Consultants éditoriaux et de codage

Michael B. First, M.D.

Maria N. Ward, M.Ed., RHIT, CCS-P

Groupes de travail du DSM-5

Déficit de l'attention/hyperactivité et troubles du comportement disruptif

DAVID SHAFFER, M.D.

Chair

F. XAVIER CASTELLANOS, M.D.

Co-Chair

Paul J. Frick, Ph.D., *Text Coordinator*

Glorisa Canino, Ph.D.

Terrie E. Moffitt, Ph.D.

Joel T. Nigg, Ph.D.

Luis Augusto Rohde, M.D., Sc.D.

Rosemary Tannock, Ph.D.

Eric A. Taylor, M.B.

Richard Todd, Ph.D., M.D. (*d. 2008*)

Troubles anxieux, du spectre obsessionnel-compulsif, post-traumatiques et dissociatifs

KATHARINE A. PHILLIPS, M.D.

Chair

Michelle G. Craske, Ph.D., *Text Coordinator*

J. Gavin Andrews, M.D.

Susan M. Bögels, Ph.D.

Matthew J. Friedman, M.D., Ph.D.

Eric Hollander, M.D. (*2007-2009*)

Roberto Lewis-Fernández, M.D., M.T.S.

Robert S. Pynoos, M.D., M.P.H.

Scott L. Rauch, M.D.

H. Blair Simpson, M.D., Ph.D.

David Spiegel, M.D.

Dan J. Stein, M.D., Ph.D.

Murray B. Stein, M.D.

Robert J. Ursano, M.D.

Hans-Ulrich Wittchen, Ph.D.

Troubles de l'enfance et de l'adolescence

DANIEL S. PINE, M.D.

Chair

Ronald E. Dahl, M.D.

E. Jane Costello, Ph.D. (*2007-2009*)

Regina Smith James, M.D.

Rachel G. Klein, Ph.D.

James F. Leckman, M.D.

Ellen Leibenluft, M.D.

Judith H. L. Rapoport, M.D.

Charles H. Zeanah, M.D.

Troubles de l'alimentation

B. TIMOTHY WALSH, M.D.

Chair

Stephen A. Wonderlich, Ph.D., *Text
Coordinator*

Evelyn Attia, M.D.

Anne E. Becker, M.D., Ph.D., Sc.M.

Rachel Bryant-Waugh, M.D.

Hans W. Hoek, M.D., Ph.D.

Richard E. Kreipe, M.D.

Marsha D. Marcus, Ph.D.

James E. Mitchell, M.D.

Ruth H. Striegel-Moore, Ph.D.

G. Terence Wilson, Ph.D.

Barbara E. Wolfe, Ph.D. A.P.R.N.

Troubles de l'humeur

JAN A. FAWCETT, M.D.

Chair

Ellen Frank, Ph.D., *Text Coordinator*
 Jules Angst, M.D. (2007-2008)
 William H. Coryell, M.D.
 Lori L. Davis, M.D.
 Raymond J. DePaulo, M.D.
 Sir David Goldberg, M.D.
 James S. Jackson, Ph.D.

Kenneth S. Kendler, M.D. (2007-2010)
 Mario Maj, M.D., Ph.D.
 Husseini K. Manji, M.D. (2007-2008)
 Michael R. Phillips, M.D.
 Trisha Suppes, M.D., Ph.D.
 Carlos A. Zarate, M.D.

Troubles neurocognitifs

DILIP V. JESTE, M.D. (2007-2011)

Chair Emeritus

DAN G. BLAZER, M.D., Ph.D., M.P.H.

Chair

RONALD C. PETERSEN, M.D., Ph.D.

Co-Chair

Mary Ganguli, M.D., M.P.H., *Text Coordinator*
 Deborah Blacker, M.D., Sc.D.
 Warachal Faison, M.D. (2007-2008)

Igor Grant, M.D.
 Eric J. Lenze, M.D.
 Jane S. Paulsen, Ph.D.
 Perminder S. Sachdev, M.D., Ph.D.

Troubles neurodéveloppementaux

SUSAN E. SWEDO, M.D.

Chair

Gillian Baird, M.A., M.B., B.Chir., *Text Coordinator*
 Edwin H. Cook Jr., M.D.
 Francesca G. Happé, Ph.D.
 James C. Harris, M.D.
 Walter E. Kaufmann, M.D.
 Bryan H. King, M.D.
 Catherine E. Lord, Ph.D.

Joseph Piven, M.D.
 Sally J. Rogers, Ph.D.
 Sarah J. Spence, M.D., Ph.D.
 Rosemary Tannock, Ph.D.
 Fred Volkmar, M.D. (2007-2009)
 Amy M. Wetherby, Ph.D.
 Harry H. Wright, M.D.

Troubles de la personnalité¹

ANDREW E. SKODOL, M.D.

Chair

JOHN M. OLDHAM, M.D.

Co-Chair

Robert F. Krueger, Ph.D., *Text Coordinator*
 Renato D. Alarcon, M.D., M.P.H.
 Carl C. Bell, M.D.
 Donna S. Bender, Ph.D.

Lee Anna Clark, Ph.D.
 W. John Livesley, M.D., Ph.D. (2007-2012)
 Leslie C. Morey, Ph.D.
 Larry J. Siever, M.D.
 Roel Verheul, Ph.D. (2008-2012)

1. Les membres du groupe de travail sur les troubles de la personnalité sont responsables du Modèle alternatif pour les troubles de la personnalité du DSM-5 proposé section III. Les troubles de la personnalité de la section II, critères et texte (avec actualisation du texte), sont conservés depuis le DSM-IV-TR.

Troubles psychotiques

WILLIAM T. CARPENTER JR., M.D.

Chair

Deanna M. Barch, Ph.D., *Text Coordinator*

Juan R. Bustillo, M.D.

Wolfgang Gaebel, M.D.

Raquel E. Gur, M.D., Ph.D.

Stephan H. Heckers, M.D.

Dolores Malaspina, M.D., M.S.P.H.

Michael J. Owen, M.D., Ph.D.

Susan K. Schultz, M.D.

Rajiv Tandon, M.D.

Ming T. Tsuang, M.D., Ph.D.

Jim van Os, M.D.

Troubles sexuels et de l'identité sexuelle

KENNETH J. ZUCKER, PH.D.

Chair

Lori Brotto, Ph.D., *Text Coordinator*

Irving M. Binik, Ph.D.

Ray M. Blanchard, Ph.D.

Peggy T. Cohen-Kettenis, Ph.D.

Jack Drescher, M.D.

Cynthia A. Graham, Ph.D.

Martin P. Kafka, M.D.

Richard B. Krueger, M.D.

Niklas Långström, M.D., Ph.D.

Heino F.L. Meyer-Bahlburg, Dr. rer. nat.

Friedemann Pfäfflin, M.D.

Robert Taylor Segraves, M.D., Ph.D.

Troubles du sommeil

CHARLES F. REYNOLDS III, M.D.

Chair

Ruth M. O'Hara, Ph.D., *Text Coordinator*

Charles M. Morin, Ph.D.

Allan I. Pack, Ph.D.

Kathy P. Parker, Ph.D., R.N.

Susan Redline, M.D., M.P.H.

Dieter Riemann, Ph.D.

Troubles à symptomatologie somatique

JOEL E. DIMSDALE, M.D.

Chair

James L. Levenson, M.D., *Text Coordinator*

Arthur J. Barsky III, M.D.

Francis Creed, M.D.

Nancy Frasurre-Smith, Ph.D. (2007-2011)

Michael R. Irwin, M.D.

Francis J. Keefe, Ph.D. (2007-2011)

Sing Lee, M.D.

Michael Sharpe, M.D.

Lawson R. Wulsin, M.D.

Troubles liés à une substance

CHARLES P. O'BRIEN, M.D., Ph.D.

Chair

THOMAS J. CROWLEY, M.D.

Co-Chair

Wilson M. Compton, M.D., M.P.E.,
Text Coordinator

Marc Auriacombe, M.D.

Guilherme L. G. Borges, M.D., Dr.Sc.

Kathleen K. Bucholz, Ph.D.

Alan J. Budney, Ph.D.

Bridget F. Grant, Ph.D., Ph.D.

Deborah S. Hasin, Ph.D.

Thomas R. Kosten, M.D. (2007-2008)

Walter Ling, M.D.

Spero M. Manson, Ph.D. (2007-2008)

A. Thomas McLellan, Ph.D. (2007-2008)

Nancy M. Petry, Ph.D.

Marc A. Schuckit, M.D.

Wim van den Brink, M.D., Ph.D. (2007-2008)

Groupes d'études du DSM-5

Spectre diagnostique et harmonisation DSM/CIM

STEVEN E. HYMAN, M.D.

Chair (2007-2012)

William T. Carpenter Jr., M.D.

Wilson M. Compton, M.D., M.P.E.

Jan A. Fawcett, M.D.

Helena C. Kraemer, Ph.D.

David J. Kupfer, M.D.

William E. Narrow, M.D., M.P.H.

Charles P. O'Brien, M.D., Ph.D.

John M. Oldham, M.D.

Katharine A. Phillips, M.D.

Darrel A. Regier, M.D., M.P.H.

Approches développementales sur la durée de vie

ERIC J. LENZE, M.D.

Chair

SUSAN K. SCHULTZ, M.D.

Chair Emeritus

DANIEL S. PINE, M.D.

Chair Emeritus

Dan G. Blazer, M.D., Ph.D., M.P.H.

F. Xavier Castellanos, M.D.

Wilson M. Compton, M.D., M.P.E.

Daniel T. Mamah, M.D., M.P.E.

Andrew E. Skodol II, M.D.

Susan E. Swedo, M.D.

Questions liées au genre et interculturelles

KIMBERLY A. YONKERS, M.D.

Chair

ROBERTO LEWIS-FERNÁNDEZ, M.D., M.T.S.

Co-Chair, Cross-Cultural Issues

Renato D. Alarcon, M.D., M.P.H.

Diana E. Clarke, Ph.D., M.Sc.

Javier I. Escobar, M.D., M.Sc.

Ellen Frank, Ph.D.

James S. Jackson, Ph.D.

Spiro M. Manson, Ph.D. (2007-2008)

James P. McNulty, A.B., Sc.B.

Leslie C. Morey, Ph.D.

William E. Narrow, M.D., M.P.H.

Roger Peele, M.D.

Philip Wang, M.D., Dr.P.H. (2007-2012)

William M. Womack, M.D.

Kenneth J. Zucker, Ph.D.

Interface psychiatrie/médecine générale

LAWSON R. WULSIN, M.D.

Chair

Ronald E. Dahl, M.D.

Joel E. Dimsdale, M.D.

Javier I. Escobar, M.D., M.Sc.

Dilip V. Jeste, M.D. (2007-2011)

Walter E. Kaufmann, M.D.

Richard E. Kreipe, M.D.

Ronald C. Petersen, Ph.D., M.D.

Charles F. Reynolds III, M.D.

Robert Taylor Segraves, M.D., Ph.D.

B. Timothy Walsh, M.D.

Déficiences et handicap

JANE S. PAULSEN, Ph.D.

Chair

J. Gavin Andrews, M.D.

Glorisa Canino, Ph.D.

Lee Anna Clark, Ph.D.

Diana E. Clarke, Ph.D., M.Sc.

Michelle G. Craske, Ph.D.
Hans W. Hoek, M.D., Ph.D.
Helena C. Kraemer, Ph.D.

William E. Narrow, M.D., M.P.H.
David Shaffer, M.D.

Instruments d'évaluation diagnostique

JACK D. BURKE JR., M.D., M.P.H.

Chair

Lee Anna Clark, Ph.D.
Diana E. Clarke, Ph.D., M.Sc.
Bridget F. Grant, Ph.D., Ph.D.

Helena C. Kraemer, Ph.D.
William E. Narrow, M.D., M.P.H.
David Shaffer, M.D.

Groupe de recherche du DSM-5

WILLIAM E. NARROW, M.D., M.P.H.

Chair

Jack D. Burke Jr., M.D., M.P.H.
Diana E. Clarke, Ph.D., M.Sc.
Helena C. Kraemer, Ph.D.

David J. Kupfer, M.D.
Darrel A. Regier, M.D., M.P.H.
David Shaffer, M.D.

Spécifications d'évolution et glossaires

WOLFGANG GAEBEL, M.D.

Chair

Ellen Frank, Ph.D.
Charles P. O'Brien, M.D., Ph.D.
Norman Sartorius, M.D., Ph.D., *Consultant*
Susan K. Schultz, M.D.

Dan J. Stein, M.D., Ph.D.
Eric A. Taylor, M.B.
David J. Kupfer, M.D.
Darrel A. Regier, M.D., M.P.H.

Classification du DSM-5

Les codes de la CIM-9-MC¹, suivis des codes de la CIM-10-MC² entre parenthèses, apparaissent avant le nom de chaque trouble. Des lignes vides indiquent que le code de la CIM-9-MC ou bien celui de la CIM-10-MC n'est pas applicable. Pour certains troubles, un code ne peut être indiqué qu'en fonction du sous-type ou de la spécification.

Il était prévu aux États-Unis que la CIM-9-MC soit utilisée pour le codage jusqu'au 30 septembre 2014 et qu'elle soit remplacée dans cet usage par la CIM-10-MC à partir du 1^{er} octobre 2014³.

Les numéros des pages du texte ou des critères apparaissent entre parenthèses à la suite des titres des chapitres et des noms des troubles correspondants.

Note pour tous les troubles mentaux dus à une autre affection médicale : inclure le nom de l'autre affection médicale dans le nom du trouble mental dû à [l'affection médicale]. Le code et le nom de l'autre affection médicale doivent être notés en premier, immédiatement avant le trouble mental dû à l'affection médicale.

Troubles neurodéveloppementaux (p. 33)

Handicaps intellectuels (p. 35)

—	(—)	Handicap intellectuel (trouble du développement intellectuel) (p. 35) <i>Spécifier la sévérité actuelle :</i>
317	(F70)	Léger
318.0	(F71)	Moyen
318.1	(F72)	Grave
318.2	(F73)	Profond
315.8	(F88)	Retard global du développement (p. 44)
319	(F79)	Handicap intellectuel (trouble du développement intellectuel) non spécifié (p. 45)

Troubles de la communication (p. 45)

315.32	(F80.2)	Trouble du langage (p. 45)
315.39	(F80.0)	Trouble de la phonation (p. 48)
315.35	(F80.81)	Trouble de la fluidité verbale apparaissant durant l'enfance (bégaiement) (p. 50)
N.B. : Les cas plus tardifs sont cotés 307.0 (F98.5) trouble de la fluidité verbale débutant à l'âge adulte.		

1. Classification internationale des maladies, 9^e révision – Modifications cliniques.

2. Classification internationale des maladies, 10^e révision – Modifications cliniques.

3. NDT. Le Sénat des États-Unis a approuvé le 31 mars 2014 un projet de loi dont l'une des dispositions est de retarder d'un an, c'est-à-dire jusqu'au 1^{er} octobre 2015, la date d'utilisation de la CIM-10-MC.

315.39 (F80.89) Trouble de la communication sociale (pragmatique) (p. 53)

307.9 (F80.9) Trouble de la communication non spécifié (p. 55)

Trouble du spectre de l'autisme (p. 55)

299.00 (F84.0) Trouble du spectre de l'autisme (p. 55)

Spécifier si : Associé à une pathologie médicale ou génétique connue ou à un facteur environnemental ; Associé à un autre trouble développemental, mental ou comportemental

Spécifier la sévérité actuelle des critères A et B : Nécessitant une aide très importante ; Nécessitant une aide importante ; Nécessitant de l'aide

Spécifier si : Avec ou sans déficit intellectuel associé ; Avec ou sans altération du langage associée, Avec catatonie (utiliser le code additionnel 293.89 [F06.1])

Déficit de l'attention/hyperactivité (p. 67)

____ (____) Déficit de l'attention/hyperactivité (p. 67)

Spécifier le type :

314.01 (F90.2) Présentation combinée

314.00 (F90.0) Présentation inattentive prédominante

314.01 (F90.1) Présentation hyperactive/impulsive prédominante

Spécifier si : En rémission partielle

Spécifier la sévérité actuelle : Léger, Moyen, Grave

314.01 (F90.8) Autre déficit de l'attention/hyperactivité spécifié (p. 75)

314.01 (F90.9) Déficit de l'attention/hyperactivité non spécifié (p. 75)

Trouble spécifique des apprentissages (p. 76)

____ (____) Trouble spécifique des apprentissages (p. 76)

Spécifier si :

315.00 (F81.0) Avec déficit de la lecture (*spécifier* si exactitude de la lecture des mots, rythme et fluidité de la lecture, compréhension de la lecture)

315.2 (F81.81) Avec déficit de l'expression écrite (*spécifier* si exactitude en orthographe, exactitude en ponctuation et en grammaire, clarté ou organisation de l'expression écrite)

315.1 (F81.2) Avec déficit du calcul (*spécifier* si sens des nombres, mémorisation de faits arithmétiques, calcul exact ou fluide, raisonnement mathématique correct)

Spécifier la sévérité actuelle : Léger, Moyen, Grave

Troubles moteurs (p. 86)

315.4 (F82) Trouble développemental de la coordination (p. 86)

- 307.3 (F98.4)** Mouvements stéréotypés (p. 90)
Spécifier si : Avec comportement d'automutilation, Sans comportement d'automutilation
Spécifier si : Associé à une affection médicale ou génétique connue, un trouble neurodéveloppemental ou un facteur environnemental
Spécifier la sévérité actuelle : Léger, Moyen, Grave

Tics

- 307.23 (F95.2)** Syndrome de Gilles de la Tourette (p. 94)
307.22 (F95.1) Tics moteurs ou vocaux persistants (chroniques) (p. 94)
Spécifier si : Avec tics moteurs exclusivement, Avec tics vocaux exclusivement
307.21 (F95.0) Tics provisoires (p. 95)
307.20 (F95.8) Autres tics spécifiés (p. 99)
307.20 (F95.9) Tics non spécifiés (p. 100)

Autres troubles neurodéveloppementaux (p. 100)

- 315.8 (F88)** Autre trouble neurodéveloppemental spécifié (p. 100)
315.9 (F89) Trouble neurodéveloppemental non spécifié (p. 101)

Spectre de la schizophrénie et autres troubles psychotiques (p. 109)

Les spécifications suivantes s'appliquent au spectre de la schizophrénie et aux autres troubles psychotiques quand cela est indiqué :

^a *Spécifier si* : Les spécifications de l'évolution qui suivent ne doivent être utilisées qu'après une durée d'un an du trouble : Premier épisode, actuellement en épisode aigu ; Premier épisode, actuellement en rémission partielle ; Premier épisode, actuellement en rémission complète ; Épisodes multiples, actuellement épisode aigu ; Épisodes multiples, actuellement en rémission partielle ; Épisodes multiples, actuellement en rémission complète ; Continu ; Non spécifié

^b *Spécifier si* : Avec catatonie (utiliser le code additionnel 293.89 [F06.1])

^c *Spécifier la sévérité actuelle* des idées délirantes, des hallucinations, de la désorganisation du discours, des comportements psychomoteurs anormaux, des symptômes négatifs, du déficit cognitif, de la dépression et des symptômes maniaques

- 301.22 (F21)** Personnalité schizotypique (p. 112)
297.1 (F22) Trouble délirant^{a, c} (p. 113)
Spécifier le type : Type érotomane, Type mégalomane, Type de jalousie, Type de persécution, Type somatique, Type mixte, Type non spécifié
Spécifier si : Avec contenu bizarre
298.8 (F23) Trouble psychotique bref^{b, c} (p. 117)
Spécifier si : Avec facteur(s) de stress marqué(s), Sans facteur(s) de stress marqué(s), Avec début lors du post-partum

- 295.40 (F20.81)** Trouble schizophréniforme^{b,c} (p. 120)
Spécifier si : Avec caractéristiques de bon pronostic, Sans caractéristiques de bon pronostic
- 295.90 (F20.9)** Schizophrénie^{a,b,c} (p. 122)
- ____ (____) Trouble schizoaffectif^{a,b,c} (p. 130)
Spécifier le type :
- 295.70 (F25.0)** Type bipolaire
- 295.70 (F25.1)** Type dépressif
- ____ (____) Trouble psychotique induit par une substance/un médicament^c (p. 136)
N.B. : Cf. les critères et les procédures d'enregistrement correspondantes des codes spécifiques aux substances et les codes de la CIM-9-MC et de la CIM-10-MC.
Spécifier si : Avec début au cours d'une intoxication, Avec début au cours d'un sevrage
- ____ (____) Trouble psychotique dû à une autre affection médicale^c (p. 142)
Spécifier le type :
- 293.81 (F06.2)** Avec idées délirantes
- 293.82 (F06.0)** Avec hallucinations
- 293.89 (F06.1)** Catatonie associée à un autre trouble mental (spécification de type catatonique) (p. 146)
- 293.89 (F06.1)** Trouble catatonique dû à une autre affection médicale (p. 147)
- 293.89 (F06.1)** Catatonie non spécifiée (p. 149)
N.B. : Coder d'abord **781.99 (R29.818)** autres symptômes impliquant les systèmes nerveux et musculo-squelettique.
- 298.8 (F28)** Autre trouble du spectre de la schizophrénie ou autre trouble psychotique spécifié (p. 149)
- 298.9 (F29)** Trouble du spectre de la schizophrénie ou autre trouble psychotique non spécifié (p. 150)

Troubles bipolaires et apparentés (p. 157)

Les spécifications suivantes s'appliquent aux troubles bipolaires et apparentés quand cela est indiqué :

^a *Spécifier : Avec détresse anxiieuse (spécifier la sévérité actuelle : léger, moyen, moyen-grave, grave) ; Avec caractéristiques mixtes ; Avec cycles rapides ; Avec caractéristiques mélancoliques ; Avec caractéristiques atypiques ; Avec caractéristiques psychotiques congruentes à l'humeur ; Avec caractéristiques psychotiques non congruentes à l'humeur ; Avec catatonie (utiliser le code additionnel 293.89 [F06.1]) ; Avec début lors du péripartum ; Avec caractère saisonnier*

- ____ (____) Trouble bipolaire de type I^a (p. 157)
- ____ (____) Épisode maniaque actuel ou le plus récent
- 296.41 (F31.11)** Léger
- 296.42 (F31.12)** Moyen

296.43 (F31.13)	Grave
296.44 (F31.2)	Avec caractéristiques psychotiques
296.45 (F31.73)	En rémission partielle
296.46 (F31.74)	En rémission complète
296.40 (F31.9)	Non spécifié
296.40 (F31.0)	Épisode hypomaniaque actuel ou le plus récent
296.45 (F31.71)	En rémission partielle
296.46 (F31.72)	En rémission complète
296.40 (F31.9)	Non spécifié
—.— (—.—)	Épisode dépressif actuel ou le plus récent
296.51 (F31.31)	Léger
296.52 (F31.32)	Moyen
296.53 (F31.4)	Grave
296.54 (F31.5)	Avec caractéristiques psychotiques
296.55 (F31.75)	En rémission partielle
296.56 (F31.76)	En rémission complète
296.50 (F31.9)	Non spécifié
296.7 (F31.9)	Épisode actuel ou le plus récent, non spécifié
296.89 (F31.81)	Trouble bipolaire de type II ^a (p. 167) <i>Spécifier</i> l'épisode actuel ou le plus récent : Hypomaniaque, Dépressif <i>Spécifier</i> l'évolution si les critères complets pour un épisode thymique ne sont pas remplis actuellement : En rémission partielle, En rémission complète <i>Spécifier</i> la sévérité si les critères complets pour un épisode thymique sont remplis actuellement : Léger, Moyen, Grave
301.13 (F34.0)	Trouble cyclothymique (p. 175) <i>Spécifier</i> si : Avec détresse anxieuse
—.— (—.—)	Trouble bipolaire ou apparenté induit par une substance/un médicament ⁴ (p. 178) N.B. : Cf. les critères et les procédures d'enregistrement correspondantes des codes spécifiques aux substances et les codes de la CIM-9-MC et de la CIM-10-MC. <i>Spécifier</i> si : Avec début au cours d'une intoxication, Avec début au cours d'un sevrage
293.83 (—.—)	Trouble bipolaire ou apparenté dû à une autre affection médicale (p. 182) <i>Spécifier</i> si : (F06.33) Avec caractéristiques maniaques (F06.33) Avec épisode d'allure maniaque ou hypomaniaque (F06.34) Avec caractéristiques mixtes

4. NDT. Dans les intitulés diagnostiques de ce type, où la mention du trouble comprend plusieurs éléments coordonnés par la conjonction *and* /et, nous avons choisi d'utiliser à la place la conjonction de coordination « ou » afin que l'intitulé diagnostique puisse rester au singulier.

296.89 (F31.89) Autre trouble bipolaire ou apparenté spécifié (p. 185)

296.80 (F31.9) Trouble bipolaire ou apparenté non spécifié (p. 186)

Troubles dépressifs (p. 193)

Les spécifications suivantes s'appliquent aux troubles dépressifs quand cela est indiqué :

^a *Spécifier* : Avec détresse anxieuse (*spécifier* la sévérité actuelle : léger, moyen moyen-grave, grave) ; Avec caractéristiques mixtes ; Avec caractéristiques mélancoliques ; Avec caractéristiques atypiques ; Avec caractéristiques psychotiques congruentes à l'humeur ; Avec caractéristiques psychotiques non congruentes à l'humeur ; Avec catatonie (utiliser le code additionnel 293.89 [F06.1]) ; Avec début lors du péripartum ; Avec caractère saisonnier

296.99 (F34.8) Trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle (p. 194)

—.— (—.—) Trouble dépressif caractérisé^a (p. 200)

—.— (—.—) Épisode isolé

296.21 (F32.0) Léger

296.22 (F32.1) Moyen

296.23 (F32.2) Grave

296.24 (F32.3) Avec caractéristiques psychotiques

296.25 (F32.4) En rémission partielle

296.26 (F32.5) En rémission complète

296.20 (F32.9) Non spécifié

—.— (—.—) Épisode récurrent

296.31 (F33.0) Léger

296.32 (F33.1) Moyen

296.33 (F33.2) Grave

296.34 (F33.3) Avec caractéristiques psychotiques

296.35 (F33.41) En rémission partielle

296.36 (F33.42) En rémission complète

296.30 (F33.9) Non spécifié

300.4 (F34.1) Trouble dépressif persistant (dysthymie)^a (p. 209)

Spécifier si : En rémission partielle, En rémission complète

Spécifier si : Début précoce, Début tardif

Spécifier si : Avec syndrome dysthymique pur ; Avec épisode dépressif caractérisé persistant ; Avec épisodes dépressifs caractérisés intermittents, y compris l'épisode actuel ; Avec épisodes dépressifs caractérisés intermittents, mais pas au cours de l'épisode actuel

Spécifier la sévérité actuelle : Léger, Moyen, Grave

625.4 (N94.3) Trouble dysphorique prémenstruel (p. 212)

—.— (—.—) Trouble dépressif induit par une substance/un médicament (p. 216)